



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.512 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre o Regimento Interno das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, no uso das suas atribuições legais que lhe conferem o inciso III do §1º do art. 93 da Constituição Estadual e o art. 43 da Lei Estadual nº 24.313, de 28 de abril de 2023, e considerando:

- a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
- a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
- a Lei Estadual nº 11.983, de 14 de novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES – e dá outras providências;
- o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- o Decreto Estadual nº 49.080, de 01 de agosto de 2025, que dispõe sobre as normas de transferência, monitoramento, prestação de contas e avaliação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde.;
- a Resolução SES/MG nº 10.382, de 11 de agosto de 2025 que dispõe sobre as regras de aplicação do Decreto Estadual nº 49.080 de 01 de agosto de 2025;
- a necessidade de organizar o processo de acompanhamento das metas e indicadores previstos nas Resoluções de financiamento das Políticas Estaduais de Saúde formalizadas por termo.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado, nos termos desta Resolução, o Regimento Interno da Comissão Macrorregional de Acompanhamento (CMA), instituída pelo art. 20 do Decreto Estadual nº 49.080, de 01 de agosto de 2025.

Parágrafo único - Para efeito do Regimento, considera-se:

I.Área técnica: responsável pela elaboração, monitoramento, execução orçamentária e financeira da política pública de saúde concernente ao objeto da Resolução de financiamento e avaliação de seus resultados.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

II.Área gestora: responsável pelo apoio estratégico complementar à implementação e ao monitoramento das políticas públicas de saúde e dos contratos assistenciais, em articulação com as Unidades Regionais de Saúde.

III.Unidade Regional de Saúde: responsável pela execução complementar e descentralizada das ações relacionadas à implementação das políticas públicas de saúde e dos contratos assistenciais no âmbito dos territórios.

IV.Beneficiário: entes estabelecidos no art. 3º do Decreto Estadual nº 49.080, de 01 de agosto de 2025, contemplado pelas resoluções de financiamento e Termo de Adesão da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

V.Monitoramento: atividade que visa ao acompanhamento sistemático e análise periódica da execução orçamentária, do desempenho dos indicadores e outras condicionantes aplicadas a uma Resolução de financiamento, de modo a medir e registrar o desempenho dos beneficiários e produzir informações estratégicas para a gestão da estratégia ou projeto.

VI.Indicadores declaratórios: indicadores cujo resultado é informado pelo próprio beneficiário, não havendo repositórios públicos de dados.

VII.Indicadores oficiais: indicadores cujo resultado é extraído de sistema de informação ou base de dados disponível publicamente.

VIII.Ciência de resultados: procedimento pelo qual o beneficiário é formalmente informado dos resultados apurados dos indicadores vinculados a determinada Resolução de financiamento, sendo-lhe assegurado o direito de manifestação, por meio de interposição de recurso, em caso de discordância.

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 2º - A Comissão Macrorregional de Acompanhamento (CMA) é uma instância de caráter permanente, deliberativo e de abrangência macrorregional, conforme Plano Diretor de Regionalização, com competência para deliberar sobre os recursos interpostos pelos beneficiários quanto aos resultados das metas e indicadores das Estratégias de Saúde (ES) ou Projetos de Saúde (PS).

Art. 3º – As Comissões Macrorregionais de Acompanhamento são gerenciadas pela Diretoria de Monitoramento de Políticas de Saúde (DMPS), vinculada à Subsecretaria de Regionalização (SUBR) da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

Parágrafo único - A Comissão disposta no caput deste art. 2º, poderá monitorar, manifestar ou deliberar sobre outros projetos, processos ou ações, conforme demanda da Subsecretaria de Regionalização (SUBR).

CAPÍTULO II



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º - Cada macrorregião de saúde constituirá três Comissões Macrorregionais de Acompanhamento, divididas por área de atuação:

- I – Acesso a Serviços de Saúde;
- II – Redes de Atenção à Saúde; e
- III – Vigilância em Saúde.

Art. 5º - As Comissões Macrorregionais de Acompanhamento serão compostas por um (1) coordenador, representantes das Unidades Regionais de Saúde (URS) das respectivas coordenações que compõem a temática de cada comissão e representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG), vinculados à respectiva macrorregião.

§1º - A quantidade de membros por macrorregião e por área de atuação encontra-se previsto no Anexo I desta Resolução.

§ 2º - Para cada membro titular será formalmente designado um (1) suplente.

§ 3º - Os representantes do COSEMS/MG devem ser preferencialmente secretários(as) municipais de Saúde, sendo possível a indicação de servidor(a) municipal, desde que formalizada, nos moldes do art. 7º.

Art. 6º - A coordenação das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento deverá ser exercida pelo coordenador formal da unidade administrativa correspondente à área de atuação, no âmbito da Unidade Regional de Saúde responsável pela coordenação da Comissão Intergestores Bipartite Macrorregional (CIB Macro), conforme disposto a seguir:

I. Comissão de Acesso a Serviços de Saúde: será coordenada pelo responsável formal da Coordenação de Acesso a Serviços de Saúde (CASES) ou pela Coordenação de Assistência Farmacêutica (CAF), da Unidade Regional de Saúde responsável pela CIB Macro, observando-se a possibilidade de alternância entre titularidade e suplência entre essas duas coordenações. A definição quanto à indicação dos coordenadores titulares e suplentes, caberá ao Dirigente Regional, a quem compete decidir sobre a melhor composição, conforme a realidade organizacional e operacional da respectiva Regional de Saúde.

II. Comissão de Redes de Atenção à Saúde: será coordenada pelo responsável formal da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (CRAS) da Unidade Regional de Saúde coordenadora da Comissão Intergestores Bipartite Macrorregional (CIB Macro).

III. Comissão de Vigilância em Saúde: será coordenada pelo responsável formal da Coordenação de Vigilância em Saúde (CVS) da Unidade Regional de Saúde coordenadora da Comissão Intergestores Bipartite Macrorregional (CIB Macro). § 1º Nos casos de macrorregião bipolar, poderá ser conveniado a alternância da coordenação titular e suplente entre as unidades regionais de saúde polo da macrorregião.

§ 1º - Excepcionalmente para a Macrorregião Centro, em virtude de Belo Horizonte ser polo estadual e do volume de recursos, fica autorizado que seja indicado coordenador suplente das URS de Sete Lagoas ou Itabira.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

§ 2º - Nos casos de macrorregião bipolar, poderá ser convencionado a alternância da coordenação titular e suplente entre as unidades regionais de saúde polo da macrorregião.

Art. 7º – A indicação dos membros titulares e suplentes das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento de cada macrorregião, conforme previsto no Anexo I, deverá ser formalizada:

I - Por ofício do COSEMS Regional, dirigido à respectiva unidade regional de saúde, para os membros COSEMS/MG.

II - Por memorando, assinado pelo dirigente da Unidade Regional de Saúde responsável pela coordenação da CIB Macro, contendo o quadro geral com as informações dos membros titulares e suplentes, conforme modelo previsto no Anexo II.

§ 1º – A formalização dos membros mencionados no caput deste artigo, deverá ser encaminhada à Diretoria de Monitoramento de Políticas de Saúde (DMPs), vinculada à Subsecretaria de Regionalização (SUBR) da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG), por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

§ 2º - As futuras alterações na composição poderão ser formalizadas diretamente pelo dirigente de Unidade Regional de Saúde que não seja a responsável pela coordenação da CIB Macro, desde que seja obedecido os trâmites do § 1º e encaminhada também à Unidade Regional de Saúde coordenadora da CIB Macro.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Art. 8º - São atribuições dos membros das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento de cada Unidade Regional de Saúde da respectiva macrorregião:

I – Analisar os pedidos de recursos e demais documentos comprobatórios interpostos pelos beneficiários da área de abrangência de sua respectiva Unidade Regional de Saúde, registrados em Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde.

II – Receber a pauta e a convocação da reunião da Comissão Macrorregional de Acompanhamento, encaminhadas pelo coordenador e, previamente à reunião, comunicar qualquer impossibilidade de participação, acionando o respectivo suplente para assegurar a presença e a representatividade da Unidade Regional.

III – Comparecer, seja de forma online ou presencial, às reuniões convocadas pelos coordenadores das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento, contribuindo ativamente para as discussões sobre os recursos interpostos, com objetividade e transparência.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

IV – Deliberar sobre os pedidos de recurso por meio de manifestação de voto, considerando notas técnicas e decisões anteriores sobre o mesmo tema.

V – Auxiliar na elaboração da ata, quando solicitado, e formalizar assinatura na versão disponibilizada pelo coordenador no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

VI – Atualizar os resultados dos indicadores relacionados aos pedidos de recursos deferidos, referentes aos beneficiários vinculados à respectiva Unidade Regional de Saúde no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde.

VII – Auxiliar o coordenador, quando solicitado, na divulgação do resultado final da avaliação dos recursos durante a reunião da CIB Macrorregional.

VIII – Declarar suspeição ou impedimento nos casos em que o objeto da pauta apresente conflito de interesses.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES

Art. 9º - São atribuições dos coordenadores das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento de cada Macrorregião de Saúde:

I – Analisar os pedidos de recursos e demais documentos comprobatórios interpostos pelos beneficiários da área de abrangência de sua respectiva Unidade Regional de Saúde, registrados em Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde.

II – Elaborar a pauta para a reunião da Comissão Macrorregional de Acompanhamento.

III – Responsabilizar-se pela gestão documental de todo o processo e garantir aos membros acesso irrestrito a toda a documentação comprobatória consolidada juntamente com os recursos.

IV – Definir a data da reunião, organizar a logística, seja online ou presencial, encaminhar a pauta e convocar os membros.

V – Coordenar a reunião, conduzindo as discussões e deliberações sobre os recursos interpostos de maneira objetiva e transparente.

VI – Deliberar sobre os pedidos considerando notas técnicas e decisões anteriores sobre o mesmo tema e, em caso de empate, proferir o voto de desempate, acompanhado de justificativa para a decisão.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

VII – Elaborar a ata da reunião e, caso a macrorregião abranja mais de uma Unidade Regional de Saúde, solicitar a colaboração dos membros na sua elaboração e registro no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde.

VIII – Disponibilizar no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ata da reunião para assinatura dos membros votantes.

IX – Atualizar os resultados dos indicadores relacionados aos pedidos de recursos deferidos, referentes aos beneficiários vinculados à respectiva Unidade Regional de Saúde da macrorregião no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde.

X – Divulgar o resultado final da avaliação dos recursos na reunião da CIB Macrorregional.

XI – Declarar suspeição ou impedimento nos casos em que o objeto da pauta apresente conflito de interesses.

DAS ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS REGIONAIS

Art. 10 – São atribuições das áreas técnicas regionais das Unidades Regionais de Saúde responsáveis pelo monitoramento das estratégias ou projetos de saúde vinculados às temáticas tratadas nas Comissões Macrorregionais de Acompanhamento:

I – Emitir parecer técnico complementar sobre o recurso interposto pelo beneficiário, quando solicitado.

II – Contribuir para a elaboração da ata da reunião da Comissão Macrorregional de Acompanhamento, quando solicitado.

III – Auxiliar na divulgação do resultado final da avaliação dos recursos na reunião da CIB Macrorregional, quando necessário.

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO

Art. 11 – O processo de monitoramento dos indicadores das resoluções de financiamento da SES/MG, relacionados às estratégias ou projetos de saúde, inclui uma etapa recursal na qual os beneficiários podem apresentar recursos contra os resultados apurados dos indicadores pactuados.

Art. 12 – A interposição de recursos, acompanhada de justificativa e dos demais documentos comprobatórios, deverá ser formalizada pelos beneficiários no prazo estabelecido na normativa vinculada à estratégia ou projeto de saúde em Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Art. 13 – O acompanhamento do recurso, desde sua interposição até a divulgação dos resultados, será de responsabilidade dos membros das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento (CMA's), conforme a área de abrangência da Unidade Regional de Saúde na macrorregião dos beneficiários recorrentes.

Art. 14 – A reunião da Comissão Macrorregional de Acompanhamento poderá ser realizada de forma presencial ou online, utilizando sistemas de videoconferência ou outros recursos tecnológicos de transmissão síncrona de áudio e vídeo.

§ 1º – A participação é restrita aos membros da comissão, ressalvadas as hipóteses em que a critério do coordenador da Comissão, for considerada indispensável a presença de especialistas ou técnicos para atender aos interesses da pauta.

§ 2º – A reunião só poderá ser iniciada com a presença de quórum mínimo, equivalente à maioria absoluta dos membros titulares, e com a participação de, no mínimo, um membro do COSEMS.

§ 3º – O quórum mínimo da reunião deverá ser comprovado por meio do registro dos participantes na ata da reunião devidamente formalizada via Sistema Eletrônico de Informações (SEI/MG).

Art. 15 – As decisões das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento deverão ser tomadas com base nas justificativas e demais documentos comprobatórios formalizados pelos beneficiários, dentro do prazo estipulado e no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais.

§ 1º – Recursos apresentados sem a justificativa ou documentação tempestiva serão indeferidos de ofício, não sendo necessária a realização de reunião para apreciação.

§ 2º – A deliberação será realizada por votação individual do coordenador da comissão e dos demais membros, sendo o resultado final definido pela maioria simples.

§ 3º – Em caso de empate na votação, caberá ao coordenador da Comissão Macrorregional de Acompanhamento decidir o resultado do recurso, conforme disposto no inciso VI do art. 9º desta Resolução.

Art. 16 – As reuniões das Comissões deverão ser registradas em ata contendo a identificação dos votos de cada membro e os motivos preponderantes que fundamentaram a deliberação final.

§ 1º – A ata deverá registrar, em caso de deferimento, as alterações necessárias nas variáveis de apuração do indicador ou correção do percentual de pagamento, possibilitando a identificação do novo valor a ser pago ao beneficiário.

§ 2º – As atas das reuniões deverão ser assinadas pelo coordenador e pelos membros participantes via Sistema Eletrônico de Informações (SEI/MG).

§ 3º – Uma cópia da ata poderá ser fornecida aos beneficiários, com os votos nominais suprimidos, a fim de resguardar a privacidade dos membros das comissões.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Art. 17 - Os recursos provenientes de políticas formalizadas por meio de termos de adesão, compromissos ou metas, celebrados antes da publicação desta resolução, serão analisados pelas comissões macrorregionais de acompanhamento, conforme estabelecido no art. 31 do Decreto nº 49.080, de 01 de agosto de 2025 e no art. 44 da Resolução SES/MG nº 10.382, de 11 de agosto de 2025.

Art. 18 - Ficam revogadas as Resoluções 8.880 de 17 de julho de 2023 e 9.439 de 10 de abril de 2024.

Art. 19 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO BACCHERETTI VITOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO I - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES MACRORREGIONAIS DE ACOMPANHAMENTO

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE			MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS BELO HORIZONTE	URS ITABIRA	URS SETE LAGOAS		
CENTRO	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	4	2	2	8	17
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	4	2	2	8	17
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	4	2	2	8	17
TOTAIS		3	12	6	6	24	51

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE		MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS BARBACENA	URS SÃO JOÃO DEL REI		
CENTRO SUL	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	1	2	5
TOTAIS		3	3	3	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO	TOTAL
			URS POUSO ALEGRE		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

				COSEMS	
EXTREMO SUL	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	2	2	5
TOTAIS		3	6	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS DIAMANTINA		
JEQUITINHONHA	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	2	2	5
TOTAIS		3	6	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS GOVERNADOR VALADARES		
LESTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	2	2	5
TOTAIS		3	6	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE		MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS MANHUAÇU	URS PONTE NOVA		
LESTE DO SUL	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	1	2	5
TOTAIS		3	3	3	6	15



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE		MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS PEDRA AZUL	URS TEÓFILO OTONI		
NORDESTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	1	2	5
TOTAIS		3	3	3	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE		MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS PATOS DE MINAS	URS UNAÍ		
NOROESTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	1	2	5
TOTAIS		3	3	3	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE			MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS JANUÁRIA	URS MONTES CLAROS	URS PIRAPORA		
NORTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	1	1	3	7
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	1	1	3	7
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	1	1	3	7
TOTAIS		3	3	3	3	9	21



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS DIVINÓPOLIS		
OESTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	2	2	5
TOTAIS		3	6	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE				MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS JUIZ DE FORA	URS LEOPOLDINA	URS MANHUAÇA	URS UBÁ		
SUDESTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	1	1	1	4	9
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	1	1	1	4	9
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	1	1	1	4	9
TOTAIS		3	3	3	3	3	12	27

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE		MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS ALFENAS	URS PASSOS		
SUDOESTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	1	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	1	2	5



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

TOTAIS	3	3	3	6	15
---------------	----------	----------	----------	----------	-----------

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS VARGINHA		
SUL	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	2	2	5
TOTAIS		3	6	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS ITUIUTABA		
TRIÂNGULO DO NORTE	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	1	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	1	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	1	2	5
TOTAIS		3	3	6	15

MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS UBERABA		
TRIÂNGULO DO SUL	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	2	2	5



MACRORREGIÃO	COMISSÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO	COORDENADORES TITULARES	MEMBROS TITULARES DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE	MEMBROS TITULARES DO COSEMS	TOTAL
			URS CORONEL FABRICIANO		
VALE DO AÇO	COMISSÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	1	2	2	5
	COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	2	2	5
TOTAIS		3	6	6	15

[illegible]